

病史摘要（面诊用）

患者：CAO Yujie（护照拼音；中文姓名以本人身份证件为准）· 女 · 1997年8月8日出生（29岁）· 现居澳大利亚悉尼 · 未生育

本摘要由患者及其伴侣整理（2026年8月31日），供北京面诊参考。所有原始英文报告随附；影像原始DICOM光盘/U盘随身携带（14个序列、342幅图像，含增强扫描）。

一、影像诊断（2026-08-18，悉尼 I-MED 腰骶椎 MRI 平扫+增强，放射科 Dr U Ridley 报告）

- 脊髓圆锥位于 L4，被一巨大马尾脂肪瘤栓系（脊髓栓系综合征）。
- 脂肪瘤大小 121 × 49 × 20 mm（T1/T2高信号、压脂序列信号减低、无强化），圆锥后部变形。
- 脂肪瘤延伸进入左侧神经孔，包裹左 L5 神经根；左侧侧隐窝受压，左 S1 神经节受压。
- S1 水平 16 × 16 mm 强化的皮下肿块，考虑皮毛窦（dermal sinus），与骶部皮肤标记相对应（照片在手机里；至今无红肿、无分泌物；未触碰）。
- 无脊髓纵裂；无椎间盘突出、无椎管狭窄。

二、终生（先天性模式）病史 —— 转诊信中未包含的关键信息

- 终生活约肌功能障碍：自幼严重便秘（4–6天一次大便；儿时有憋便、需家长干预史）；终生尿频、急迫性尿失禁；性快感缺失伴会阴部感觉减退。均为终生存在，并非新发。
- 终生左下肢不对称：左腿自幼比右腿凉；左小腿、大腿较细；左腿略短；单侧左侧高弓足伴爪形趾（照片在手机里）；左侧足尖走/足跟走较弱。
- 骶部皮肤标记：骶部皮肤有标记（照片），与 MRI 上的皮毛窦位置对应。

三、近12个月进行性加重（约2025年8月起）

- 疼痛：左侧单一连续条带 —— 自左侧阴道口边缘（S3）→ 大腿后侧（S2）→ 足跟（S1）。近端有自发放电样疼痛，压迫可缓解，平躺时最重。目前更持续、仍在加重。
- 新发运动症状：左侧足尖走/足跟走无力加重。
- 大便习惯改变（2026年8月）：由终生便秘转为间断稀便，可能伴感知减退 —— 与腿部症状加重同时出现。

四、客观检查记录

日期	检查	关键结果
2025-10-08	尿动力学检查（悉尼）	峰值尿流率 12 ml/s、排尿中断型；残余尿 60→300 ml；初始尿意 100 ml；膀胱容量仅 300 ml；多次逼尿肌过度活动伴一次漏尿；尿道闭合压正常（63 cmH ₂ O）。结合 MRI 判读：神经源性膀胱表现。（全文中译随附）
2026-08-24	悉尼皇家阿尔弗雷德王子医院（RPA）急诊，神经外科会诊	查体（出院小结原文）：「左下肢整体运动功能减退，肛门括约肌张力减低，鞍区感觉异常」。神经外科要求行腰椎 CT，证实脂肪瘤。予出院、安排神经外科门诊。（出院小结中译随附）
2026-08-24	血液检查（RPA）	凝血功能正常（PT 11.6s / APTT 35s / INR 1.1）；血型 B 型 Rh 阳性，抗体筛查阴性；CRP <0.3 mg/L（皮毛窦无感染征象）；肝肾功能大致正常，eGFR 84（29岁略偏低，建议随访——已有残余尿300ml背景）。（全表中译随附）
2026-08-27	RPA 神经外科门诊（Dr David Wilson）	查体证实左下肢神经功能缺损（与 MRI 及病史一致）。因其不做成人脊髓栓系手术，建议转诊。未加做检查。

五、用药、过敏及一般情况

- 无长期用药（从未使用口服避孕药或抗抑郁药；2025年处方米拉贝隆 50mg 但从未服用）。
- 无已知药物过敏（NKA）。
- 未生育；计划将来怀孕（已知需孕前补充叶酸5mg；关注手术与怀孕的先后与间隔）。
- 子宫后位；无脱垂。一般健康状况良好。